

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 11

Espondilolisis, Espondilolistesis

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio

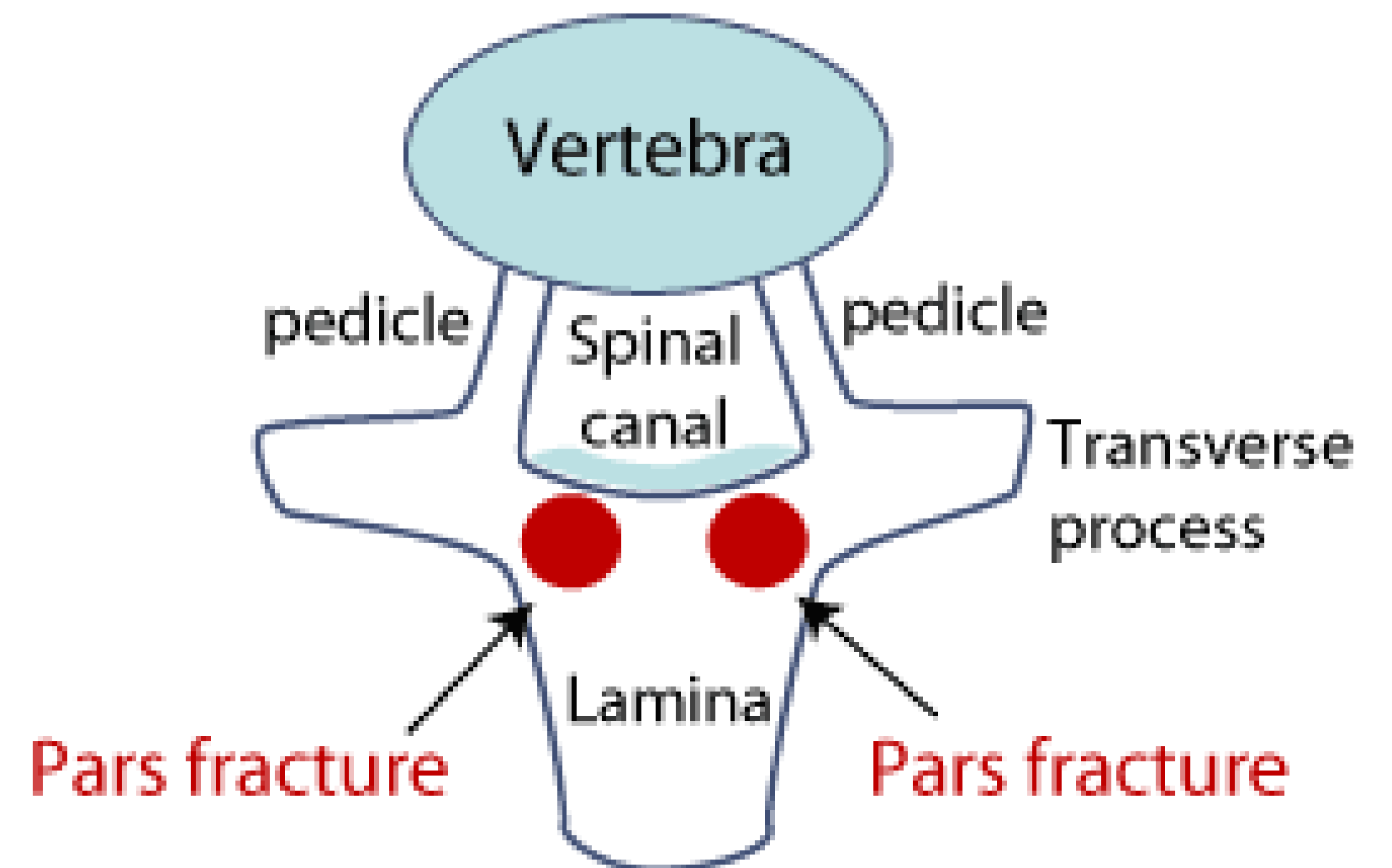
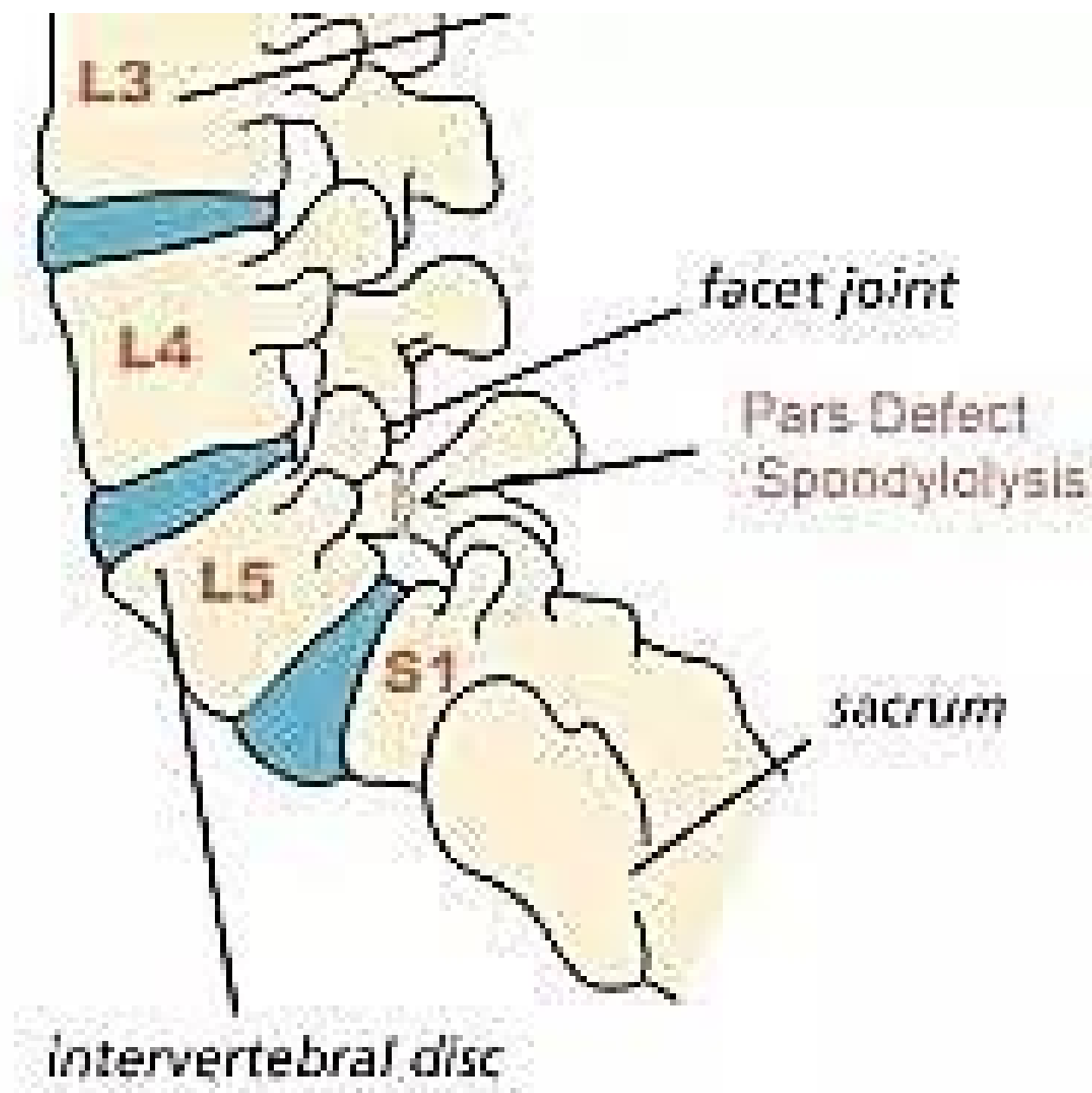
TEMARIO

- Fisiopatología
- Tratamiento Ortopédico
- Tratamiento Quirúrgico
- Tratamiento Rehabilitador



ESPONDILOLISIS

La espondilolisis es un defecto o fractura por estrés en la pars interarticularis de la vértebra (comúnmente L5).

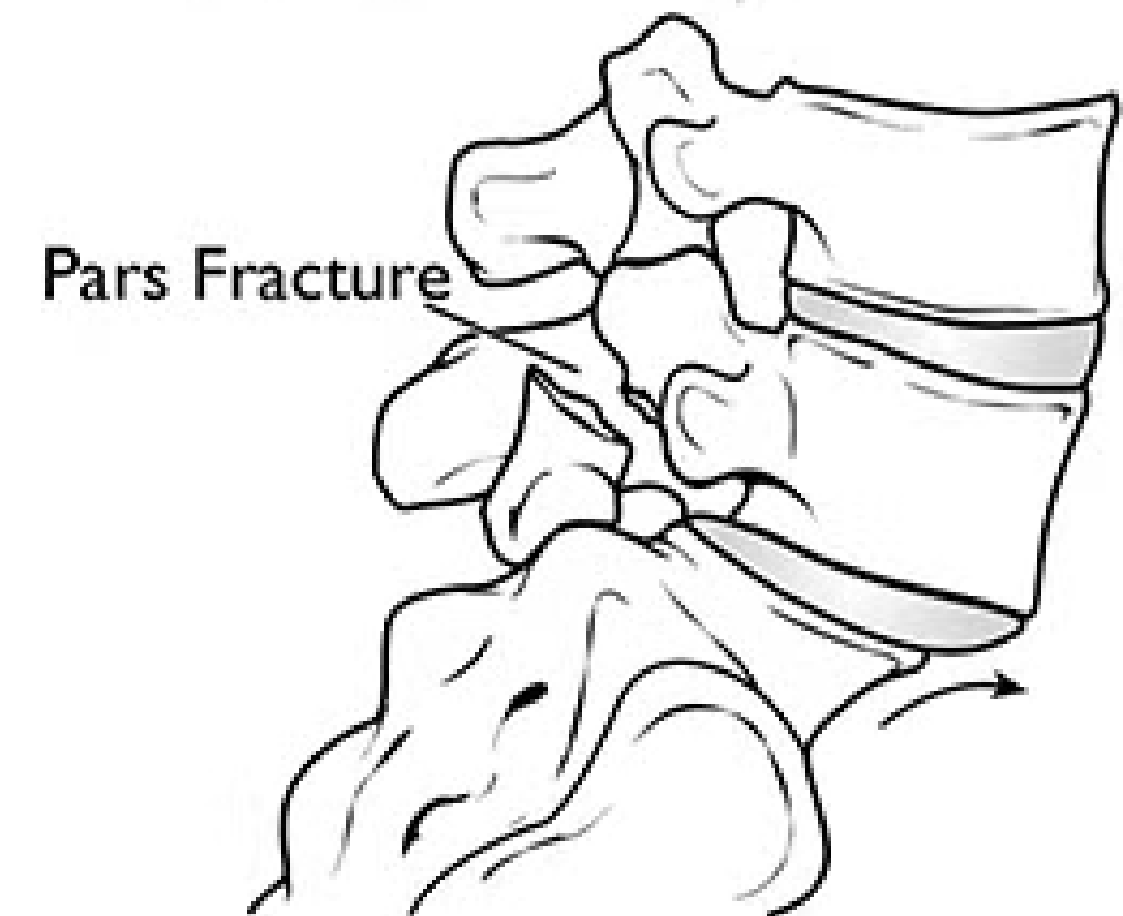
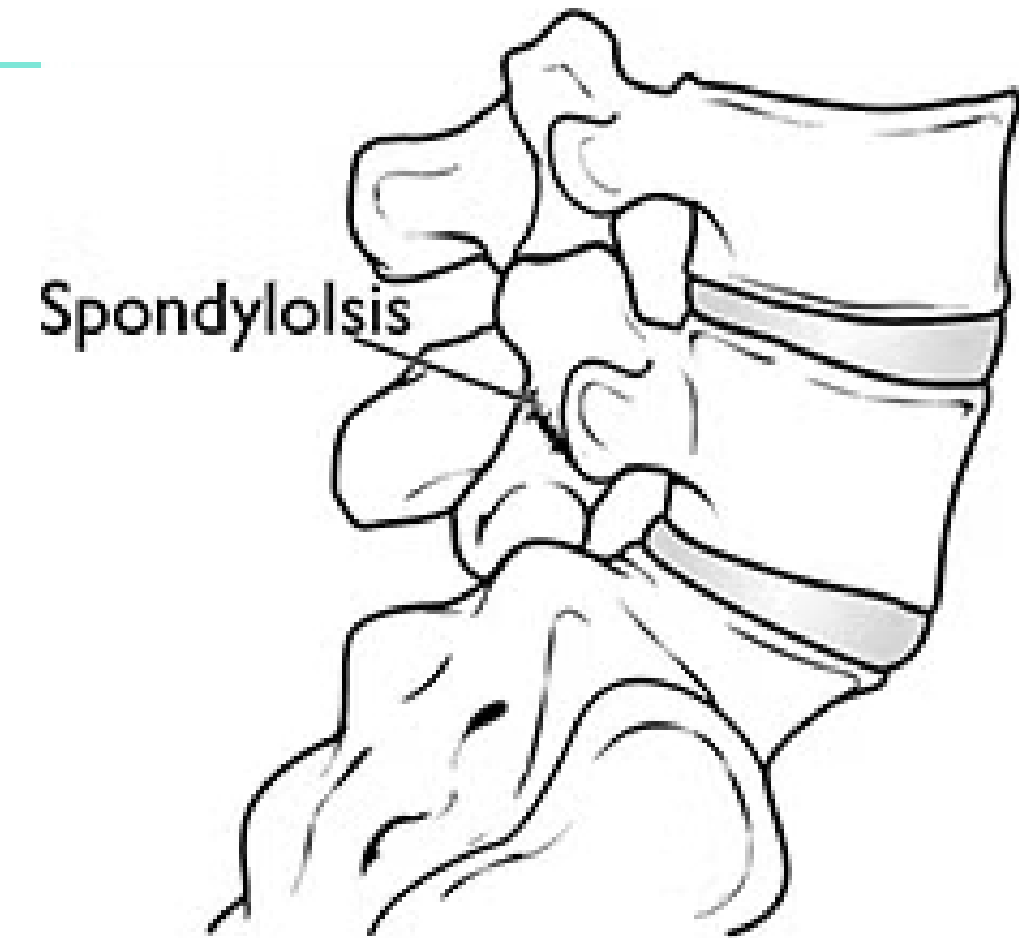


Mecanismo de Lesión: La carga repetitiva de la columna en ***hiperextensión y rotación*** genera una gran presión sobre la pars interarticularis (una pequeña porción de hueso que conecta las facetas articulares superior e inferior).



Proceso Patológico :

- *Reacción al estrés/Edema óseo*: La fatiga ósea inicial sin fractura visible.
- *Fractura por estrés (Espondilolisis)*: Una grieta o ruptura completa, generalmente unilateral o bilateral.
- *Pseudoartrosis*: Si el defecto no cura, los extremos óseos no se unen, formando una falsa articulación.



Factores Contribuyentes:

El crecimiento óseo acelerado (niños/adolescentes), predisposición genética, hiperlordosis lumbar exagerada y actividades de alto impacto (gimnasia, fútbol, halterofilia).



TRATAMIENTO ORTÉSICO

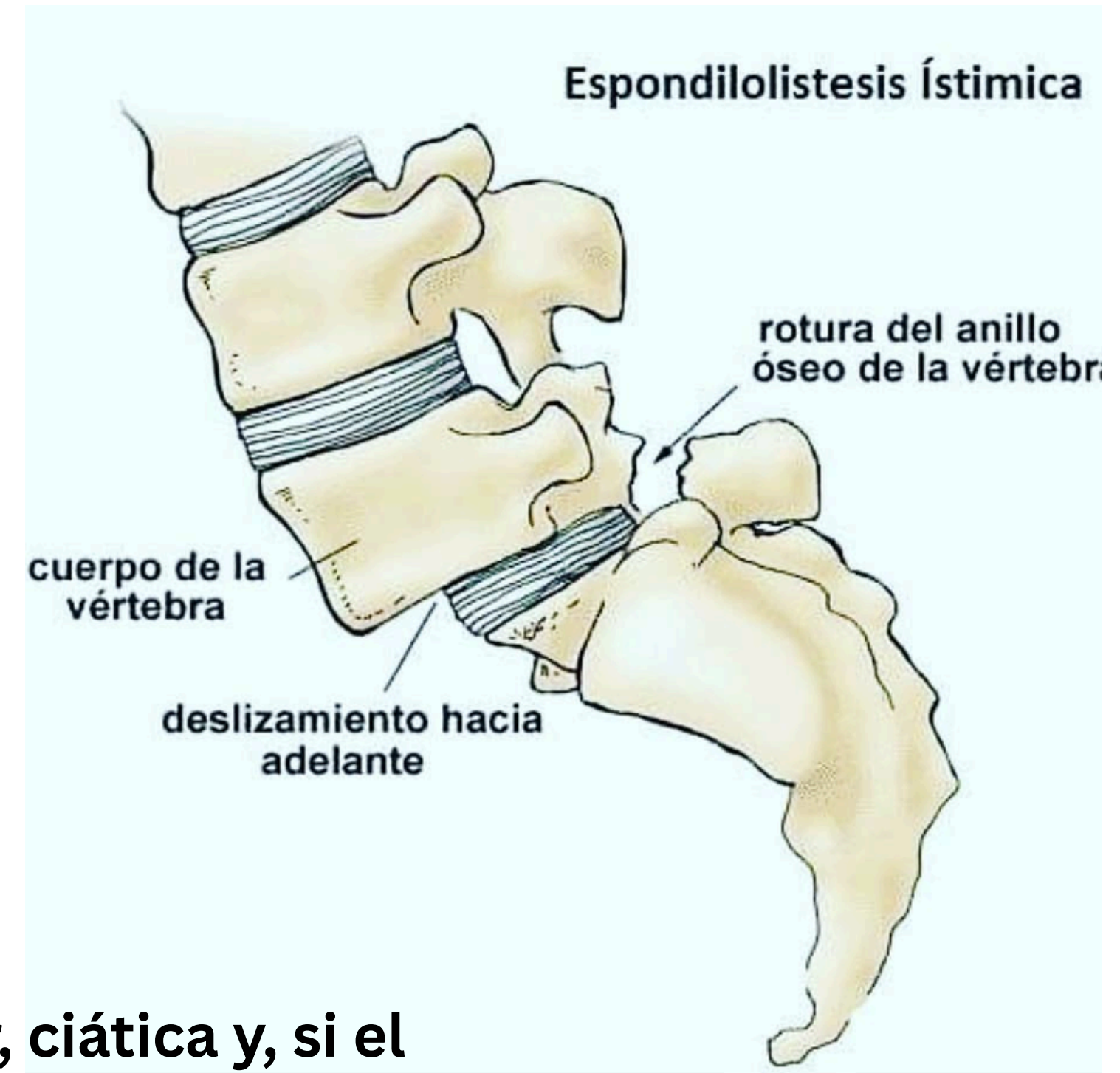
- Limitar la extensión lumbar, reducir la carga sobre la vértebra afectada y facilitar la cicatrización ósea en casos agudos, especialmente en adolescentes.



ESPONDILOLISTESIS

Es deslizamiento, generalmente anterior (anterolistesis), de una vértebra sobre la inferior, provocado por la rotura (espondilólisis) o degeneración de los elementos posteriores (articulaciones facetarias) que estabilizan la columna lumbar (comúnmente L4-L5 o L5-S1).

Esto genera inestabilidad mecánica, dolor lumbar, ciática y, si el deslizamiento progresa, estrechamiento del canal medular.



CONGÉNITA
tipo I

Malformación ósea congénita en las carillas articulares sacras, facilitando el deslizamiento anterior de L5 sobre S1.

ISTMICA
tipo II

Lesión en pars interarticularis. Puede originarse por microtraumatismos repetidos o una fractura por estrés haciendo que cuerpo vertebral se deslice hacia adelante.

DEGENERATIVA
tipo III

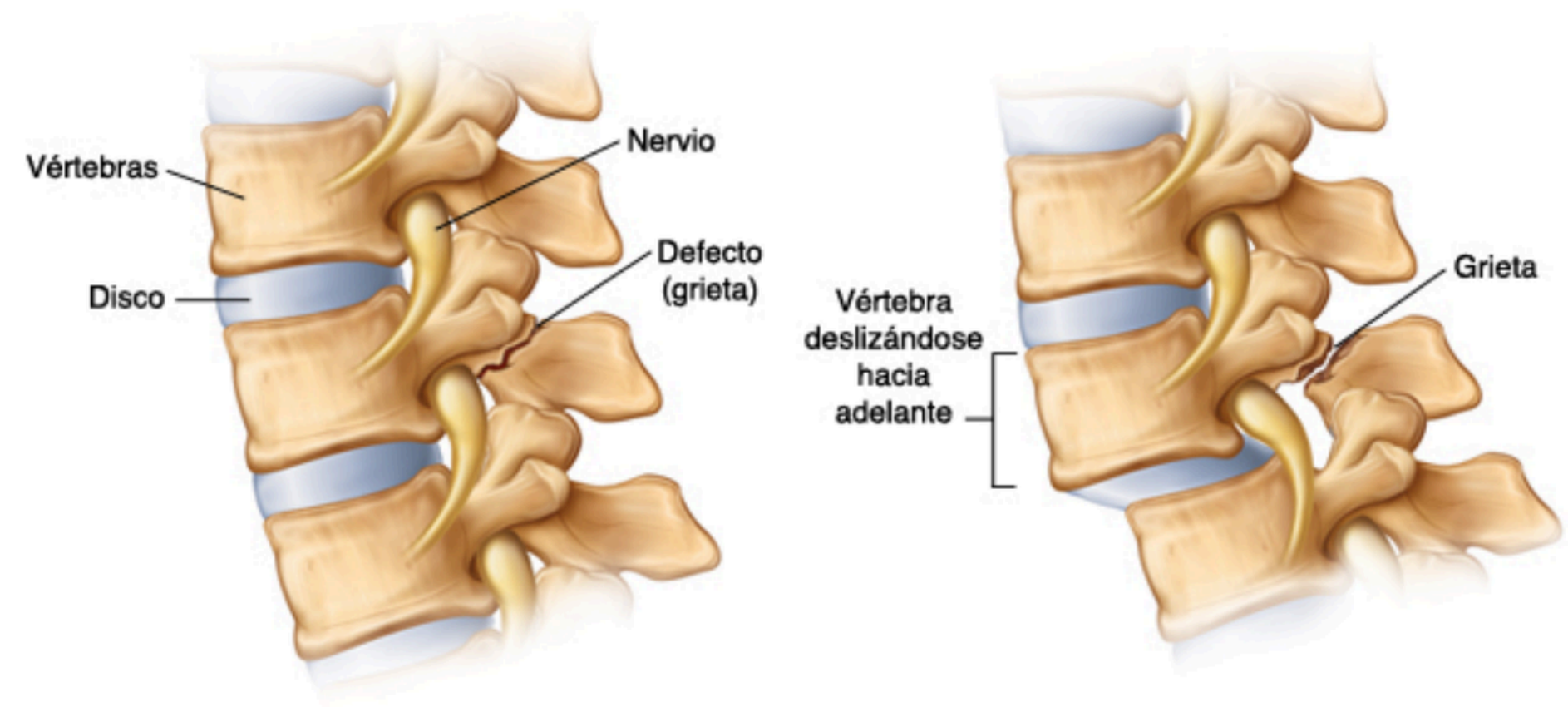
Típica en adultos mayores, especialmente mujeres posmenopáusicas. Se debe a la artrosis de las articulaciones facetarias y la degeneración del disco intervertebral.

TRAUMÁTICA
tipo IV

Resulta de una fractura aguda en elementos posteriores distintos a la pars interarticularis debido a un traumatismo de alta energía.

El desplazamiento altera la biomecánica espinal, lo que puede causar:

- Dolor mecánico: Debido a la inestabilidad.
- Dolor radicular/ciática: Por compresión de las raíces nerviosas al estrecharse el foramen o el canal medular (estenosis).
- Hiperlordosis: El deslizamiento suele aumentar la curvatura lumbar.



Espondilolistesis

TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tratamiento ortésico para la espondilolistesis busca estabilizar la columna, reducir el dolor y limitar el movimiento, **siendo eficaz principalmente en deslizamientos <50%.**





[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



- **Hospitalización (Días 1-4):** Se inicia deambulación asistida en las primeras 24-48 horas. Se maneja el dolor con medicación.
- **Primeras 4-6 semanas (Fase inicial):** Enfocada en la cicatrización y el caminar progresivo. Evitar sedestación prolongada, no flexionar, girar la columna ni cargar peso.
- **Semanas 6-12 (Rehabilitación activa):** Inicio de ejercicios suaves, fisioterapia, natación, caminar y retomar actividades laborales ligeras.
- **A partir de 3-6 meses:** Fortalecimiento muscular más intenso, retorno a la vida normal, evitando esfuerzos extremos.

Muchas gracias

Presente.